ORIGEM DO DOCUMENTO:	UTI ADU – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO		
TÍTULO:			Nº DOC:
SBAR PASSAGEM DE PLANTÃO DOS ENFERMEIROS			FRM.UTIADU.001
DATA 1ª VERSÃO	**DATA DESTA VERSÃO**	**VERSÃO Nº**	**PRÓXIMA REVISÃO**
18/12/2025	18/12/2025	001	18/12/2027

1. OBJETIVO

1.1 A utilização da ferramenta SBAR na passagem de plantão de enfermagem tem como objetivo padronizar a comunicação entre os profissionais, assegurando a continuidade, a segurança e a qualidade da assistência prestada ao paciente. Por meio de uma estrutura organizada e sistematizada, o SBAR contribui para a transmissão clara, objetiva e completa das informações clínicas e assistenciais relevantes, reduzindo falhas de comunicação e minimizando riscos de eventos adversos.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Esta ferramenta aplica-se aos profissionais enfermeiros assistenciais da FCECON, em todas as UTIs, durante a passagem de plantão, devendo o SBAR ser utilizado de forma padronizada na transmissão das informações clínicas e assistenciais dos pacientes, conforme normas e políticas institucionais vigentes.

3. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E RESPONSÁVEIS

3.1 Enfermeiros assistenciais responsáveis pelo plantão.

4. DESCRIÇÃO DA ROTINA E PROCEDIMENTO

Passo a Passo:

4.1 Preparação das informações: O enfermeiro do plantão que se encerra deve revisar todos os dados clínicos, registros de evolução, exames, medicações e procedimentos realizados, organizando as informações de forma sistematizada para a comunicação.

4.2 Início da passagem de plantão: A comunicação deve ocorrer preferencialmente à beira do leito, garantindo a privacidade, segurança e o mínimo de interrupções.

4.3 Transmissão das informações pelo SBAR:

- S – Situação: Estado atual do paciente, motivo da internação, condições clínicas críticas.
- B – Background (Histórico): Comorbidades, procedimentos realizados, cirurgias, alergias, medicações em uso, dispositivos e exames relevantes.
- A – Assessment (Avaliação): Sinais vitais, nível de consciência, dor, oxigenação, integridade da pele, eliminação, balanço hídrico, intercorrências do plantão.
- R – Recommendation (Recomendações): Cuidados prioritários, condutas a serem mantidas, medicações críticas, exames programados e observações importantes.

4.4 Confirmação e esclarecimento: O enfermeiro do plantão que inicia deve ouvir atentamente, esclarecer dúvidas e confirmar o entendimento das condutas, cuidados e prioridades do paciente.

4.5 Registro da passagem de plantão: Todas as informações transmitidas devem ser registradas no prontuário eletrônico ou manual, conforme protocolo institucional, garantindo rastreabilidade e continuidade assistencial.

4.6 Garantia da continuidade do cuidado: Ambos os profissionais devem assegurar que todas as condutas e recomendações sejam compreendidas e aplicadas, mantendo a conformidade com as normas, protocolos da UTI e diretrizes de segurança do paciente.

5. REFERÊNCIAS

5.1 Ministério da Saúde. Protocolos de Segurança do Paciente – Comunicação em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2017.

5.2 Institute for Healthcare Improvement (IHI). SBAR Tool: Situation-Background-Assessment-Recommendation. IHI Open School; 2015. Disponível em: http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/SBARToolkit.aspx

5.3 Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Resolução COFEN nº 358/2009 – Código de Ética e Responsabilidades do Enfermeiro. Brasília: COFEN; 2009.

6. ANEXOS:

6.1 Formulário SBAR passagem de plantão dos enfermeiros

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

SBAR – FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO E TRANSIÇÃO DE CUIDADOS EFETIVOS
PASSAGEM DE PLANTÃO ENFERMEIRO UTI ADULTO/PEDIATRICA

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

NOME:_____ **PRONTUÁRIO:** _____ **LEITO:** _____
MÃE: _____ **DATA DO NASCIMENTO:** _____
IDADE: _____ **SEXO: MASCULINO ( ) FEMININO ( )** **DATA INTERNAÇÃO:** ___/___/____
DIAGNÓSTICO: _____ **DATA ATUAL:** ____/____/_____

SITUAÇÃO
- Motivos da Internação
- Sinais Vitais

MOTIVO DA INTERNAÇÃO: ( ) Clínico: _____ Data: ___/___/____ Médico: _____
( ) Cirúrgico. Qual:_____Data: ___/____/_____/ Médico: _____
( ) Reabordagem. Data: ___/___/____ Médico:._____
1 – AVALIAÇÃO:
Nível de Consciência: ( )Acordado ( ) Orientado ( )Sonolento ( )Agitado/ Desorientado ( )Sedado
Padrão Respiratório: ( ) TQT ( ) CN 2l/min ( ) MNBZ __l/min ( ) Venturi à ___%
VM: ( )VCV ( )PCV ( )PSV **VNI:** ( )CPAP ( )BIPAP

BREVE HISTÓRICO
- Problema ativo
- Alergia
- Reconciliação Medicamentos
- Isolamento
- Dispositivos invasivos
- Curativos
- Protocolos

2- COMORBIDADES: ( ) Não ( ) Cardiopatia ( )HAS ( )DM ( )Ins. Renal ( )Doença Respiratória
Alergia medicamentosa/alimentar? SIM ( ) NÃO ( ) **Reação**:( ) Urticária ( ) Edema
Qual (is)substância(s):_____
3-ISOLAMENTO: ( )Contato ( )Imunodepressão ( )Respiratório: ( )N95 ( )Máscara Comum
Dispositivos: ( )AVP: ( ) AVC: ( ) PICC ( )PORTH-CATH ___/___/____
( )SNG/SGO_____ML (X)SVD: l ( )DFT: _____ml
Diurese: ( )Não (X)Sim: _____ Evacuação: ( )Não ( )Sim: _____
Balanço Hídrico: _____Curativo: _____
4 – NUTRIÇÃO: ( )VO ( )SNE ( )SNG Aberta: _____ml
Protocolo de Jejum: ( )Não ( )Sim. Início às: ____:____ h de ___/___/____

AVALIAÇÃO
- Riscos Assistenciais
- Cuidados de Enfermagem

5- Avaliação: Sinais Vitais: PA _____ ; FC: ____SAT O2: _____ FR:_____ TEMP:_____
GLASGLOW:_____ RASS: _____ __ BRADEN:_____ MORSE:_____
RISCOS EVIDENCIADOS: ( )Flebite ( )Infecção ( )Queda ( )Broncoaspiração ( )Hipoglicemia ( )
Hipotermia ( )Ansiedade ( )Sangramento ( )Padrão Respiratório Ineficaz ( )Lesão de Pele ( )Dor Aguda ( )
Náuseas
( )Vômito ( )PH Urinário ( )Comunicação Verbal Prejudicada ( )Controle Glicemia ( )NPH ( ) Clexane
( ) Troca de Acesso Venoso ( ) Outros: _____

RECOMENDAÇÃO
- Pendências
- Exames
- Orientações

6- PENDÊNCIAS:

Exames pendentes/ Parecer de Especialista / Culturas / Pendências / Outros	Data solicitação	Data da Realização	Resultado

Transfusão sanguínea ( ) **Quimioterapia ( )** **Radioterapia ( )** **Hemodiálise ( )**
7- EXAMES REALIZADOS: ( )RAIO-X ( )USG ( )TC ( )RNM ( )COVID19 ( )GASOMETRIA ( )LABORATÓRIO

Plantão Diurno	Plantão Noturno
_____	_____
Enfermeiro (a)	**Enfermeiro (a)**

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
001	18/12/2025	Versão Inicial

Elaboração:	Data:
ANDREA LIMA DE SOUZA MARQUES:49400991215 Assinado de forma digital por ANDREA LIMA DE SOUZA MARQUES:49400991215 Dados: 2025.12.19 09:18:01 -04'00' Andrea Lima de Souza Marques – Coordenadora do NSP JARILZA VIANA DE MENDONCA:99309130253 Assinado de forma digital por JARILZA VIANA DE MENDONCA:99309130253 Dados: 2025.12.18 17:32:06 -03'00' Jarilza Viana de Mendonça- Subgerente de Enfermagem SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:23004363291 Assinado de forma digital por SHIRLEY FRAGOSO MONTEIRO:23004363291 Dados: 2025.12.18 16:40:05 -04'00' Shirley Fragoso Monteiro – Chefe do DE gov.br Documento assinado digitalmente SIDNEY DE CASTRO RABELO Data: 18/12/2025 18:39:32-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Sidney de Castro Rabelo – Enfermeiro	18/12/2025
Aprovação:	Data: 18/12/2025
HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Assinado de forma digital por HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Hilka Flavia do Espirito Santo – DITEC	